

INFILTRACIÓN EN MANO

JJ.Morais, E. Bay, RC. Chavez

INDICACIONES

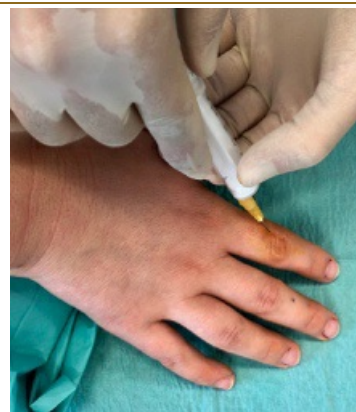
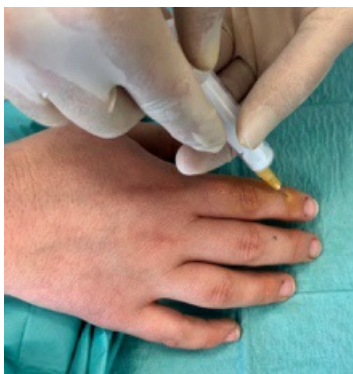
- Articulación metacarpofalángica.
- Articulación interfalángica proximal.
- Articulación interfalángica distal.
- Tendones flexores (Tenosinovitis de flexores, dedo en resorte).
- Tenosinovitis de De Quervain.
- Gangliones o quistes sinoviales.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

Articulación metacarpofalángica, IFP y IFD

- **Posición:** Mano en apoyo palmar con ligera flexión de los dedos.
- **Punto de entrada:** A nivel de la interlínea y por fuera del tendón extensor de los dedos.
- **Dirección aguja:** Oblicua en sentido distal de los dedos, en el plano oblicuo de la articulación.

- **OJO:** Evitar administración subcutánea.



Tendones flexores (Tenosinovitis de flexores, dedo en resorte)

- **Posición:** Mano en apoyo dorsal con los dedos en extensión.
- **Punto de entrada:** A nivel del engrosamiento tendinoso o zona dolorosa a ambos lados del mismo, en la cara palmar de la mano.
- **Dirección aguja:** Oblicua, casi paralela al plano cutáneo y en dirección del tendón.

- **OJO:** No infiltrar de manera intratendinosa. Si existe mucha resistencia retirar lentamente la aguja mientras se infunde hasta notar que desaparece la resistencia.



Tenosinovitis de De Quervain

- **Posición:** Mano en pronosupinación media del antebrazo, sujetando el pulgar.
 - **Punto de entrada:** a nivel del trayecto de los tendones de los músculos abductor corto y extensor largo del pulgar en el trayecto desde la base del primer metacarpiano hasta el estiloides radial.
 - **Dirección aguja:** Oblicua, casi paralela al plano cutáneo y en dirección proximal de los tendones.
- **OJO:** Evitar administración subcutánea.



Gangliones o quistes sinoviales

- **Posición:** Sentado con la mano sobre la mesa en ligera flexión palmar, para evidenciar la formación quística.
- **Punto de entrada:** en el lugar de localización del quiste, en la cara dorsal de la mano.
- **Dirección de la aguja:** Oblicua, casi paralela al plano cutáneo en sentido proximal hasta penetrar en el ganglión.
- **Procedimiento:** Evacuación del quiste, cambio de jeringa (sin retirar la aguja) e infiltración del corticoide.

MATERIAL

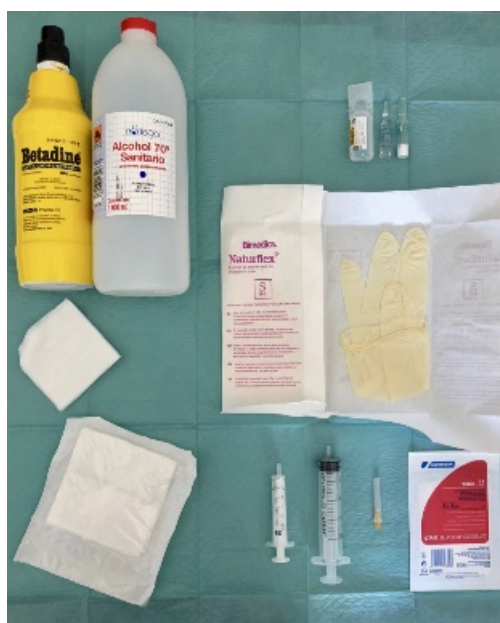
- Algodón con alcohol.
- Algodón con betadine.
- Gasas estériles.
- Vendaje adhesivo estéril.
- Algodón limpio no estéril absorbente.

Gangliones o quistes sinoviales (Infiltración opcional):

- Jeringa de 20ml.
- Jeringa de 5ml (para la infiltración opcional).
- Aguja calibre 18, de 3cm de longitud.
- Hemostato (para la infiltración opcional tras la aspiración).
- 0.25ml de Lidocaína al 1% sin Epinefrina.
- 0.25ml de solución de esteroide (10mg de Acetónido de Triamcinolona)

Resto de indicaciones:

- Jeringa de 5ml.
- Aguja calibre 25, de 3cm de longitud.
- 0.5ml de solución de esteroide (20mg de Acetónido de Triamcinolona).
- 0.5ml de Lidocaína al 1% sin Epinefrina.



BIBLIOGRAFÍA

- McNabb J. Infiltraciones. 1st ed. Madrid: Marbán; 2006; pag. 59-72.
- Vidal Fuentes J. Técnicas de infiltración articular y de tejidos blandos. 1st ed. Madrid: Luzán 5; 2015; pag. 61-82.
- Maestro Saavedra F, Hernández Tuda C, Vázquez Mascato A. Técnica de Infiltraciones en la mano [Internet]. Fisterra.com. 2011 [cita 10 Abril 2018]. Available from: <https://www.fisterra.com/ayuda-en-consulta/tecnicas-atencion-primaria/infiltraciones-mano/?avisologin=Identificacion%20realizada%20correctamente>
- Navarro Massip L, Rivero Franco I. Infiltraciones (y II) (AMF 2010) Paso a paso [Internet]. Amf-semfyc.com. 2010 [cita 10 Abril 2018]. Available from: http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=44